

表 36 ECMO 每日检查记录单 (C)

姓名		病案号		日期	20__年__月__日
年龄	____岁	床	____床	模式	☐ VA ☐ VV ☐ ECPR ☐ VAV ☐ 其他
上机时间	____月____日____时	已运行	____天____小时	班次	☐ 白班 ☐ 夜班
C 模块：患者临床状态（每班必查）					
C1. 神经系统					
检查项目	测量值		预警/异常→处理		
双侧瞳孔	左____mm /右____mm,光反射 ☐ 灵敏 ☐ 迟钝 ☐ 消失		双侧不等大、光反射消失、NPi<3→头颅 CT		
GCS 评分	E____ V____ M____ = ____ 分		GCS 下降≥2 分→查中枢原因		
RASS 镇静评分	____ 分（目标 -1~-2）		过深(-4/-5)→减量镇静;过浅(+1~+4)→追加镇静		
NIRS（脑氧）（如有）	左____% /右____%,基线____%		rSO ₂ <50%或↓>20-25%基线→查 MAP/血气/Hb,必要时 CT		
肢体活动/癫痫样动作	☐ 正常 ☐ 偏瘫 ☐ 抽搐 ☐ 肌张力异常		新异常→评估是否需要 cEEG		
C2. 呼吸系统					
检查项目	测量值		预警/异常→处理		
呼吸机模式/参数	模式____ VT____mL, PEEP____ RR____ FiO ₂ ____%		参照肺保护通气: VT 4-6mL/kg PBW, Pplat≤25cmH ₂ O		
自主呼吸/人机同步	☐ 同步 ☐ 对抗 ☐ 无自主		人机对抗→评估镇静、呼吸机设置		
痰液性状	☐ 白/清 ☐ 黄/脓 ☐ 血性 ☐ 粉红色泡沫		粉色泡沫痰→警惕肺水肿/左心淤血(VA)		
C3. 循环系统					
检查项目	测量值		预警/异常 → 处理		
MAP(平均动脉压)	____ mmHg		MAP<65mmHg→评估容量/流量/血管活性药		
脉压(PP)-VA 模式重点	____ mmHg		PP<10mmHg 或脉搏波呈平线→左心射血低/主动脉瓣未开→减流量/正性肌力/左心减压		
心率/心律	____ bpm ☐ 窦性 ☐ 房颤 ☐ 其他____		恶性心律失常→抗心律失常药/电复律		
血管活性药	去甲____ μg/kg/min, 多巴酚丁胺____其他____		剂量持续升高→病情恶化或管路功能异常		

SvO ₂ /ScvO ₂	_____ %	<60%→氧输送不足(流量/Hb/SaO ₂); <70%→需关注趋势
C4. 出凝血		
检查项目	测量值	预警/异常→处理
口腔/鼻腔/气道渗血	☐ 无 ☐ 少量 ☐ 明显	明显出血→调整抗凝+局部止血
穿刺点/引流管渗血	☐ 无 ☐ 少量 ☐ 明显	同上
消化道出血	☐ 无 ☐ 胃管出血 ☐ 黑便	消化道出血→减/停抗凝+PPI+评估
皮肤瘀斑/血肿	☐ 无 ☐ 少量 ☐ 大面积	大面积瘀斑→评估抗凝强度，排查 DIC
C5. 床旁超声（参见超声 SOP 打卡单·第二阶段；频率：VA q12h、VV q24h、ECPR q6h）		
检查项目	测量值	预警/异常→处理
今日超声是否完成？	☐ 已完成 ☐ 未做（原因_____）	运行期每日必须完成 1 次
VA 模式重点(表 22·E)	LVEF____% /LVDd____mm; AV 开放 ☐ 是 ☐ 间隔 ☐ 否;心包 ☐ 无 ☐ 有 ____mm	LV 增大/AV 持续关闭/心包增多→通知上级
VV 模式重点(表 29)	肺部: ☐ A 线 ☐ B 线 ☐ 实变<右心 TAPSE____mm	实变无改善→查原因, TAPSE<14→右心衰预警

依据：ELSO 指南（2021-2024+ELSO 抗凝指南（2021）+ELSO 神经监测共识（2024）+EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南（2024）。用途： 每班（白班/夜班）床旁逐项核对，异常项记录处理措施